EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68585
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-08-04 10:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN FRANCISCO ROMERO ROMERO			RUN	: 4.543.316-1
F.Nac	: 24-03-1941	Edad	: 82 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: EL AVELLANO 1107 PB.11 SEP			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 986760433		
Fecha Ingreso	: 29-07-2023	Fecha Egreso	: 2023-08-04 10:58:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K56.4-OTRAS OBSTRUCCIONES DEL INTESTINO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Usuario de CUP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K56.4-OTRAS OBSTRUCCIONES DEL INTESTINO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. Z93.3-COLOSTOMIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. R26.3-INMOVILIDAD(POSTRADO EN: CAMA, SILLA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente consulto en urgencia el 28/07/23 por cuadro de 2 dias sin deposiciones en colostomia y vómitos fecaloideos
Es derivado a HCHM por falta de cirujanos de turno, en chillan paciente es evaluado por cirujano de turno, Dr. Lastra quien indica manejo medico y traslado a hospital de base.
Ingresa nuevamente a HSC para hospitalizacion y manejo medico expectante
el dia 30/07 es evluado por cirujano quien evidencia deposiciones pastoas en colostomia.
Se solicito estudios imagenologicos donde no se evidenciarion factor obstructivo proximal ni distal,
Paciente con aumento de parametro inflamatorios, usuario de CUP , se solicito evaluación a Medicina interna por ITU crónica
Fonoaudiologia sugiere mantener SNG dado riesgo de aspiración
Medina interna quien de acuerdo a diagnostico de ITU y sugiere Ertapenem 1 gr EC al dia por 7 dias + amoxicilina en jarabe 1 gr c/8h por 7 dias.

Actualmente paciente mas conectado, tranquilo
hemodinamicamente estable, sin apremio ventilatorio
diuresis + deposiciones en colostomia

ex fisico:
alerta, vigil, mas conectado, se comunica verbalmente hoy
piel rosada, mucosas hidratadas, llene capilar <2s
Cardiopulmonar: RR2T NAS. MP+ SRA
Abdomen: RHA+ abdomen BDI, sin signos de irritacion peritoneal. deposiciones en ostomia

PLAN DE MANEJO:

Rehabilitacion por HODOM
Curacione por HODOM

Completar dias de tratamiento antibiotico
Curaciones en Cae

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen fresubin por SNG
2. Reposo relativo
3. Curaciones por HODOM
4. Mantener rehabilitación con KNT y Fonoaudiologia por HODOM
5. ERTAPENEM 1 GR. AMPOLLA UNIDAD 1 ampolla cada 24 hrs. por 7 dias via ENDOVENOSA
6. AMOXICILINA FRASCO 500 MILIGRAMOS / 5 MINILITROS 1 gr c/8h por 7 dias. Via oral.
7. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 5 dias via ORAL. por SNG
8. METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 5 dias via ORAL. por SNG
9. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 3 dias via ORAL. por SNG. SOS
10. Control en Cae de cirugia en 21 dias

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO